P2-T2 第二次课上-part2

产科争分夺秒急诊引产宫内胎儿，为内科的后续治疗扫清障碍。清宫术后，血浆置换、激素、利妥昔单抗，一套组合拳上去，小美的病情终于慢慢稳住了，iTTP 获得缓解。医生仔细追问，小美才想起 2 年前体检就提示过血小板低、轻度贫血，当时没在意；平时晒了太阳脸和胳膊会起红斑发痒，最近一年口腔溃疡几乎没断过，头发也一直掉。追问完，医生心里有了方向，立刻完善检查：ANA 1:1280，抗 ds-DNA （IF）1:40，1360 IU/ml (ELISA)，抗 RNP、抗 Sm 、抗 rRNP 均+++，C3、C4 显著减低，免疫球蛋白 3 项：IgG 26g/L, LA 2.2（正常范围<1.2），磷脂抗体阴性，24h 尿蛋白 1.8g，自免肝抗体谱阴性。免疫科会诊考虑**系统性红斑狼疮，**予激素冲击+免疫抑制剂。3 个月后患者行 ERCP 拔除了胆总管支架。

1. **回顾整体病史，患者诊断包括哪些？各诊断之间的关系是什么？**
2. **患者的梗阻性黄疸+溶血性黄疸，是否存在一元论（即背后一个共同使动因素）可解释？**

（下一页有彩蛋）

彩蛋：患者病情缓解后 2025 年再次自然妊娠，顺利产一男婴。目前母子均体健、恢复良好。